

KC桌面——外资精译

中国医疗健康：聚焦ADA：信达生物加入口服GLP-1竞赛；恒瑞医药新兴管线协同效应显现

在美国糖尿病协会（ADA）会议（2026年6月5-8日）召开前夕，我们强调，中国生物科技/制药公司预计将分享其代谢管线的更新，尤其关注口服GLP-1候选药物的增量更新，以信达生物的小分子GLP-1（IBI3032和IBI3042）以及恒瑞医药的口服肽类HRS-9531（GLP-1/GIP）为代表。

GLP-1口服转型正在进行中，预计中国资产将发挥更大作用：我们预计GLP-1格局将持续演变，口服GLP-1的作用日益增强，原因在于：1）Wegovy片剂和Foundayo（orforglipron）近期获批，以及2）预计其将有力抵御仿制注射用司美格鲁肽的冲击（参见我们关于仿制药进入者的最新GLP-1报告）。预计到2030年，口服减肥药市场将占据约35%的AOM TAM份额，规模超过350亿美元（参见我们美国/欧洲团队的报告），由Foundayo和Wegovy片剂引领，投资者日益关注这两种药物在初始爬坡阶段的处方趋势（Wegovy片剂追踪数据表现优异，Foundayo周TRx成为焦点）。除领先的这两款药物外，一批口服GLP-1候选药物已进入后期临床试验，其中中国贡献显著（图表1），我们预计随着管线推进，源自中国的资产将在口服GLP-1领域发挥更大作用。

图表1：我们预计随着管线推进，中国资产将在口服GLP-1领域发挥更大作用 口服GLP-1格局

中国资产 将在ADA2026分享数据的重点资产

截至2026年5月

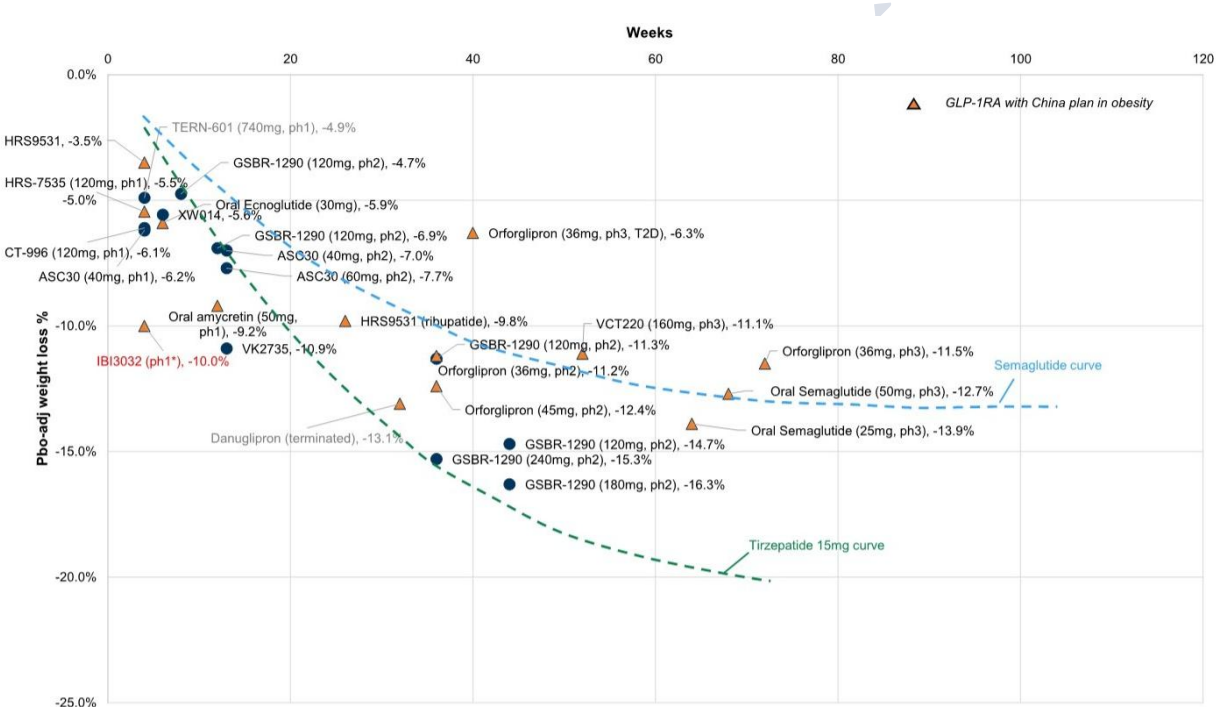
来源：PharmCube

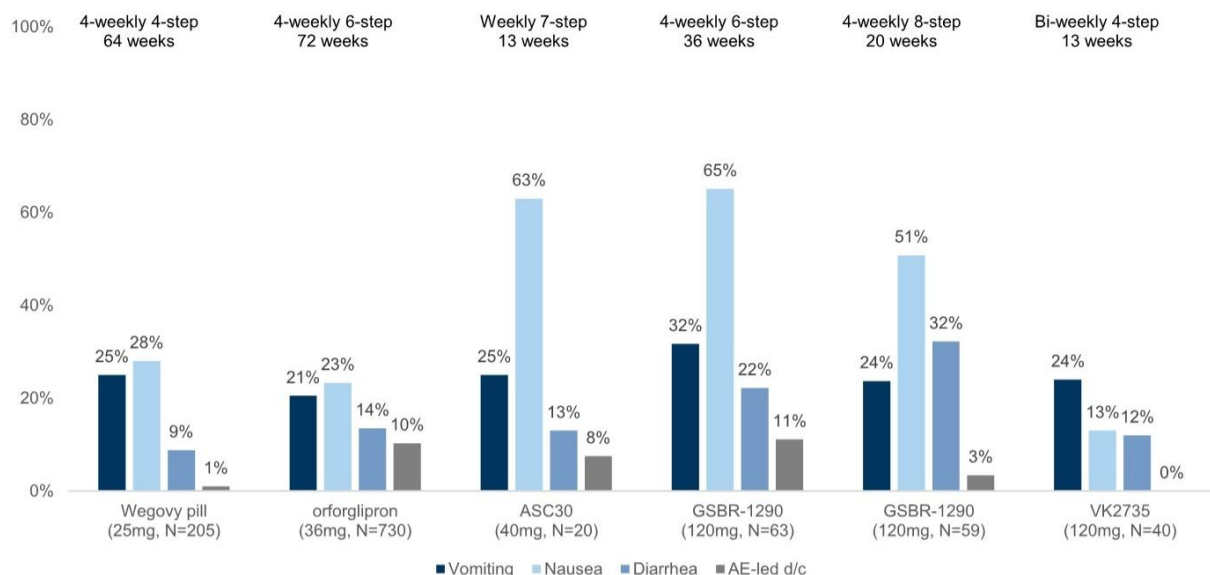
Wegovy片剂/Foundayo的3期数据设定标准，关注采用“更低更慢”策略的耐受性：我们此前曾指出（参见我们关于口服/注射辩论的中国GLP-1更新），较新的口服GLP-1资产尚未显示出相对于orforglipron具有明确竞争优势的有力临床证据，并且随着Wegovy片剂/Foundayo获批，其3期数据在疗效和耐受性方面仍具有竞争力：1）减重，并非口服GLP-1的主要关注点，因为目标人群病情较轻，且KOL认为在初级保健中10%以上的减重是可接受的，而Wegovy片剂/Foundayo的13.9%/11.5%安慰剂校正减重已将标准设定在相对较高的位置（图表2）。据我们所知，aleniglipron（GPCR-1290）是首个在更高剂量下显示出显著更高减重效果的口服GLP-1（在2期ACCESS II试验中，120mg/180mg/240mg剂量组分别减重-14.7%/-16.3%/-16%），信达生物简要分享了IBI3032在4周内实现10%减重，这可能是一个显著的差异化点，需关注ADA2026上的数据细节；2）耐受性，是口服GLP-1的主要关注点，尽管较新的口服GLP-1分子通常设计有更好的PK特征，在早期试验中显示出对胃肠道毒性的良好控制，但我们认为Wegovy片剂/Foundayo的3期数据是任何新口服GLP-1候选药物预期要超越的基准，特别是呕吐作为最严重的不良事件，预计发生率应低于20%（图表3）。此外，越来越清楚的是，采用“更低更慢”的剂量滴定策略可以有效改善耐受性（参见我们的报告），因此更多关注关键试验的设计，而早期试验（例如，当剂量滴定仍在探索中的SAD或MAD）通常可接受较大的不良事件率差异。

为IBI3032在ADA2026上的数据读出设定预期，管线价值取决于全球临床执行力：据信达生物，IBI3032的1期SAD/MAD数据将在ADA会议上分享，我们预计将看到关于该药物特征的更多细节，包括：1）样本量，尽管我们不期望公司分享所有给药患者的数据（管理层称超过100例），但20-30%（即N=20-30，而ASC30的MAD数据为24例患者）将构成相对有意义的样本量以减少随机变异；2）剂量依赖性，虽然管理层此前分享过4周治疗达到10%减重，我们希望了解相应的剂量水平（DL），以深入了解疗效窗口；3）SAD和MAD之间的耐受性差异，尽管由于处于早期阶段，不良事件率预计会有较大变异，但我们预计MAD（相对于SAD）的耐受性会有改善趋势，并初步了解IBI3032潜在的剂量滴定方案。鉴于目前口服GLP-1的格局，我们认为IBI3032的价值取决于：1）与后期同行相比的潜在差异化，以及2）全球临床执行力，需注意IBI3032大约落后aleniglipron/ASC30（两者均目标在2026年下半年启动全球3期试验）2.5年/1.5年。

恒瑞医药的新兴数据集展示管线广度和潜在协同效应：在即将召开的ADA会议上，恒瑞医药计划展示其GLP-1产品组合的多项数据集，突出口服和注射解决方案：1) HRS9531（口服GLP-1/GIP肽）将披露详细的2期肥胖症数据，此前报告在第26周实现-9.8%的减重效果；我们期待有关滴定方案和给药要求的更多细节，以评估安全性影响。除肥胖症外，HRS9531还将展示在多囊卵巢综合征中的数据，表明可能扩展到相邻的代谢适应症。2) H R17031（GLP-1/胰岛素固定剂量复方）将报告与甘精胰岛素在血糖控制不佳的糖尿病患者中的对比数据，表明其正推进至联合治疗定位。此外，恒瑞医药的口服小分子GLP-1（HRS7535）已在2型糖尿病3期试验中达到主要终点，计划于2026年提交新药申请。对于下一代多靶点药物，HRS-4729（GLP-1/GIP/GCG）在第12周显示出-16 %的减重效果（安慰剂校正-10.6%），且安全性可耐受。基于非头对头比较，疗效似乎略低于UBT251（United Labs/诺和诺德），后者在第12/24周实现了-16.6%/-17.7%的安慰剂校正减重，预计将在ADA上发布进一步的2期数据。总体而言，涵盖口服、复方和多靶点模式的数据集广度，凸显了恒瑞医药构建全谱系GLP-1产品组合的战略，其差异化可能取决于安全性、便利性和商业执行力。

图表2：在Wegovy片剂和orforglipron获批后，15%的减重正成为较新口服GLP-1的标准……
不同治疗持续时间口服GLP-1的减重数据（安慰剂校正）





图表 2

不良事件发生率为安慰剂校正 来源：公司数据

投资论点 - 恒瑞医药

恒瑞是中国领先的制药企业，目前正从“仿制药+创新药”模式向创新药业务转型。凭借强大的销售团队，恒瑞在过去几年推出了9款销售额超10亿元的药物，其中包括4款创新药。随着集采降价影响在2022年基本消化并重置至较低基数，我们预计恒瑞未来的增长动力将来自创新药，包括PARP、CDK4/6、AR拮抗剂、PI3Ki和糖尿病药物。我们给予买入评级，认为当前估值主要仅反映公司在中国的前景，海外进展应能带来进一步上行空间。我们预计当前产品周期在重磅药物PD-1放量后增速将放缓，海外进展将是公司下一个关键里程碑。主要风险：1) 创新药进入国家医保目录后放量不及预期；2) 关键后期研发项目失败风险；3) 全球扩张导致研发及管理费用超预期；4) 仿制药和创新药降价幅度超预期。

目标价风险与估值方法——恒瑞医药

我们对恒瑞给予买入评级。12个月目标价79.20元基于：1) 仿制药业务长期退出市盈率估值404亿元（基于10倍5年退出市盈率）；2) 创新药风险调整后DCF估值4207亿元（基于加权平均资本成本9.0%，终值增长率3%）。主要风险：1) 创新药进入国家医保目录后放量不及预期；2) 关键后期研发项目失败风险；3) 全球扩张导致研发及管理费用超预期；4) 仿制药和创新药降价幅度超预期；5) 授权出海/全球化进展不及预期。

投资论点——信达生物

信达生物是中国领先的生物制药公司，在免疫肿瘤领域实力雄厚，并在自身免疫/代谢/眼科领域资产不断增长。公司通过内部研发和与全球合作伙伴合作，建立了30多个资产的深厚管线，包括以信迪利单抗（覆盖国家医保目录主要适应症的领先PD-1抑制剂）为主的商业化产品。我们认为信达将继续保持在中国生物科技领域的领先地位，原因包括：1) 针对下一代免疫肿瘤靶点的新型分子管线深厚，初步数据令人鼓舞（例如IBI363（PD-1/IL-2α 偏向双抗）在免疫治疗/冷肿瘤中具有差异化药物特征，玛仕度肽（GLP-1/GCGR）在肥胖/糖尿病中显示出令人鼓舞的疗效）；2) 强大的商业化能力，信迪利单抗的快速放量即为最佳证明；3) 与全球合作伙伴（尤其是礼来）的深度合作。我们认为信达当前水平被低估，因为市场隐含的加权平均资本成本（12%）仅反映了其风险已释放适应症的价值，并未充分计入其强劲收入和管线价值。我们对该股给予买入评级。主要风险包括：1) 中国PD-1/L1市场竞争加剧；2) 关键候选药物获批时间表不确定；3) 任何安全问题可能引发的超说明书使用限制；4) 研发项目失败。

目标价风险与估值方法——信达生物

我们基于风险调整后DCF的12个月目标价为107.04港元，基于：1) 10%贴现率，2) 3%终值增长率。我们给予买入评级。主要风险包括：1) 中国PD-1/L1市场竞争加剧；2) 关键候选药物获批时间表不确定；3) 任何安全问题可能引发的超说明书使用限制；4) 研发项目失败。

公众号：KC桌面